

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE DELLA MEDICINA DELLO SPORT

Procedura operativa per la gestione delle attività
e dell'organizzazione della Medicina dello Sport

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO065_00	00	16/04/2026	8
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

1. Obiettivo

Scopo della presente procedura è descrivere le fasi e le modalità di gestione delle attività e dell'organizzazione della Medicina dello Sport, con riferimento alle visite medico-sportive agonistiche e non agonistiche presso Toscana Diagnostica S.r.l. Inoltre, ha lo scopo di definire le responsabilità e le modalità per:

1. l'esecuzione delle visite medico sportive, secondo le raccomandazioni tecniche e le normative vigenti
2. la gestione controllata delle attività di supporto correlate al processo principale

2. Campo di applicazione

La presente procedura è applicabile a tutte le attività di Medicina dello Sport gestite da Toscana Diagnostica S.r.l.

3. Termini e definizioni

Attività agonistica: comprende tutti gli sport praticati in maniera continua e costante con regolare frequenza, secondo le definizioni di cui al D.M. 18/02/1982.

Attività non agonistica: comprende le attività sportive praticate dai seguenti soggetti:

1. alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici
2. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali
3. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale

4. Riferimenti normativi

- D.M. 18/02/1982 - Norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva
- L.R. Toscana 35/2003 - Disposizioni in materia di medicina dello sport
- Circolare Ministero della Salute - Linee guida per la pratica medico-sportiva
- D.M. 24/04/2013 - Certificato non agonistico

5. Processo operativo

Le visite mediche sono effettuate mediante:

1. raccolta dati anamnestici del paziente
2. esame clinico generale e specialistico
3. esecuzione degli accertamenti previsti dalla normativa in vigore per la categoria sportiva
4. rilascio del certificato di idoneità (agonistico o non agonistico)

6. Responsabilità

Il Medico Specialista in Medicina dello Sport è responsabile della conduzione della visita medico-sportiva e del rilascio della relativa certificazione. Il personale amministrativo provvede alla registrazione dei dati e alla gestione della documentazione.

7. Tipologie di esami per categoria sportiva

1. Tabella A (sport di gruppo): calcio, pallavolo, basket, sport di contatto
2. Tabella B (sport individuali): atletica leggera, nuoto, sci, tennis, badminton

La documentazione di cui sopra è parte integrante della procedura stessa.

8. Attività

Prenotazione Accettazione e pagamento

L'atleta interessato contatta il numero dedicato (o si presenta personalmente) per le prenotazioni delle visite (in riferimento alla sede), che è possibile contattare in accordo con gli orari di apertura. La chiamata viene presa in carico da un operatore che gestirà la prenotazione, calendarizzando la visita

in funzione delle agende dei Medici. Al momento della prenotazione, l'atleta deve essere informato di tutti i documenti da portare al momento della visita. Nello specifico, deve presentarsi munito di un Documento di Identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria. In caso di visita di idoneità sportiva agonistica l'interessato deve consegnare un campione di urine il giorno antecedente alla visita e presentarsi munito di:

- modulo di richiesta Visita Sportiva Agonistica adeguatamente compilato dalla Società Sportiva richiedente o, in alternativa, modulo di richiesta personale (documento da inserire nella cartella clinica);
- libretto di idoneità alla pratica medico sportiva;
- documento sanitario comprovante l'avvenuta effettuazione della vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge (documento da inserire nella cartella clinica); deve altresì essere informato della possibilità di sottoporsi alla suddetta vaccinazione in occasione della visita sportiva stessa.

Inoltre, per entrambe le tipologie di visite sportive, siano esse finalizzate al rilascio della certificazione agonistica che non agonistica, l'interessato deve presentarsi munito di:

- abbigliamento idoneo (abiti comodi e calzature sportive);
- eventuale documentazione clinico-strumentale relativa allo stato di salute (e.g. elettrocardiogramma, ecocardiogramma, ECG dinamico secondo Holter, visite cardiologiche precedenti, etc.).

Al momento della prenotazione, l'interessato deve fornire un recapito telefonico al quale poter essere ricontatto in caso di eventuali necessità.

Il personale addetto all'accettazione al momento della prenotazione informa il paziente della necessità di presentarsi presso la struttura 10 minuti prima dell'orario indicato per la visita, al fine di consentire al personale stesso di compilare adeguatamente la documentazione necessaria in tempo per l'inizio della visita. Il personale in accettazione, all'arrivo del paziente, procede come di seguito:

- verifica l'identità del paziente e i dati di prenotazione: tipo di visita, data e ora stabilite;
- richiede al paziente la documentazione necessaria per l'accettazione;
- inserisce i dati necessari alla compilazione della cartella;
- se è il primo accesso del paziente alla struttura, viene richiesta la firma del consenso al trattamento dei dati personali;
- fa firmare "Consenso informato a pratiche cliniche straordinarie";
- Prepara ed inserisce in cartella la modulistica necessaria allo svolgimento della visita.
 - o In caso di visita agonistica dovrà essere compilato il libretto medico sportivo insieme al "Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo agonistico". Per la consegna del libretto medico sportivo verrà compilato il "Dichiarazione per il rilascio del libretto sanitario ad uso medico sportivo (Art.6-L.R. N.35/2003)". Nel caso in cui l'atleta abbia smarrito il libretto precedente dovrà compilare inoltre la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".
 - o In caso di visita non agonistica dovrà invece essere compilato il "Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico (D.M. 24.04.13)".
- Una volta compilata la documentazione, l'atleta paga la visita e si accomoda in sala in attesa di essere chiamato.
- In caso di Concorso (ministero difesa/concorso accademico militare/arruolamento/ecc..) verrà compilato il "Richiesta certificato idoneità agonistica sport per partecipazione concorso".

Attività di Back Office

Il Back Office effettua un controllo di tutta la documentazione presente e prepara e compila la documentazione necessaria durante la visita in modo tale da velocizzare la fase di accettazione e ridurre i tempi di attesa per i pazienti. In particolare, devono essere preparati e compilati:

- “Scheda clinica di valutazione medico sportiva”: verrà compilata l’anagrafica del paziente nella prima pagina. Nel caso in cui l’atleta abbia già effettuato la visita nel nostro centro, verrà recuperata dall’archivio la cartella dell’anno precedente.
- “Consenso informato a pratiche cliniche straordinarie”
- Documentazione necessaria allo svolgimento della visita ed al rilascio del giudizio conclusivo.

Nei giorni antecedenti la visita il personale di accettazione informa il medico degli orari inseriti in agenda e della pianificazione della seduta.

Consegna delle urine

In caso di visita agonistica, è prevista anche l’analisi di un campione di urina, che deve essere consegnata in uno dei nostri punti prelievi nei giorni antecedenti la visita. In alternativa, il certificato verrà consegnato una volta che il referto sarà pronto e visionato dal medico.

Esecuzione della visita medico-sportiva

L’atleta viene fatto accomodare in ambulatorio. A questo punto, il medico procede con l’anamnesi. Durante l’anamnesi, l’infermiere preparerà l’occorrente per seguire gli esami strumentali:

- ECG a riposo (elettrodi);
- ECG da sforzo (elettrodi);
- Spirometria (turbina monouso con boccaglio e filtro).

Provvederà inoltre ad inserire i dati anagrafici nei sistemi di rilevazione presenti (elettrocardiografo e computer). Terminata l’indagine anamnestica, l’infermiere procederà con la rilevazione dei parametri antropometrici (peso ed altezza). In caso di visita di idoneità sportiva agonistica, si procederà con l’esame spirometrico mediante spirometro. Terminata la spirometria si farà stendere il paziente sul lettino in decubito supino e il medico procederà con l’esame obiettivo.

Dopo aver misurato la pressione arteriosa, ove necessario, l’infermiere procederà con la tricotomia per poi applicare gli elettrodi per l’esecuzione dell’ECG a riposo (derivazioni agli arti: rosso (R) arto superiore destro (polso destro); nero (N) arto inferiore destro (caviglia destra); giallo (L) arto superiore sinistro (polso sinistro); verde (F) arto inferiore sinistro (caviglia sinistra); elettrodi precordiali: rosso (V1) quarto spazio intercostale lungo la linea marginosternale destra; giallo (V2) quarto spazio intercostale lungo la linea marginosternale sinistra; verde (V3) punto intermedio di una linea immaginaria che collega V2 a V4; marrone (V4) quinto spazio intercostale all’intersezione con la linea emiclaveare sinistra; nero (V5) quinto spazio intercostale all’intersezione con la linea ascellare anteriore; viola (V6) quinto spazio intercostale all’intersezione con la linea ascellare media).

Una volta terminato si fa alzare l’atleta per procedere con:

- STEP TEST: Test da sforzo in cui il soggetto, per un tempo stabilito di 3 minuti, sale e scende dal gradino ad una frequenza fissa (gradino di Kaltembach, la cui pedana sarà posizionata ad una altezza proporzionata all’altezza del soggetto). Durante la prova si tiene costantemente sotto controllo gli elettrodi e la loro trasmissione relativa. Al termine della prova l’atleta rimane fermo in piedi per qualche secondo per poi sdraiarsi sul lettino, over rimarrà per il periodo di recupero, durante il quale l’infermiere provvederà a misurare la PA su indicazione del medico.
- CICLOERGOMETRO: è un test da sforzo dove l’atleta, posizionato sulla cyclette, pedala mantenendo la frequenza di pedalata in un range fra 60 e 70 giri/minuto. Col passare dei minuti la cyclette aumenterà il carico di resistenza in base al protocollo deciso dal medico da opporre alla pedalata dell’atleta, in modo da aumentare la frequenza cardiaca fino a

raggiungere una FC massimale o, in alternativa, il completo esaurimento muscolare del soggetto. Allo scadere di ogni minuto verranno misurati e segnati i valori pressori.

- **ERGOMETRO A MANOVELLA:** da utilizzarsi in caso di impossibilità fisica ad utilizzare il cicloergometro da parte del paziente; l'esecuzione è analoga al test con Cicloergometro, ma vengono impegnati gli arti superiori, allo scopo di raggiungere la frequenza target per indice diagnostico. Durante tutta la durata dei test, il medico tiene sempre sotto controllo la prova, registrando i dati utili. Al termine della prova l'infermiere provvederà a liberare il paziente dai cavi dell'elettrocardiografo mentre il medico termina la compilazione della cartella clinica. In caso di visita agonistica si controlla che il referto del campione di urine sia pronto (indispensabile per la certificazione di idoneità sportiva); l'originale viene tenuto in cartella, mentre la copia viene consegnata all'atleta.

In caso di malore o evento avverso durante la visita medico sportiva, l'infermiere ed il medico agiranno tempestivamente per prestare soccorso al paziente secondo procedura sanitaria e aziendale e registrando l'evento nel relativo modulo, il quale verrà archiviato e conservato.

Alla fine di tutte le valutazioni clinico-strumentali, in caso di esito positivo della visita, verrà consegnato al paziente il certificato di idoneità sportiva e il libretto sportivo (in caso di visita di idoneità sportiva agonistica); qualora, al contrario, secondo il parere del medico fossero necessari ulteriori esami aggiuntivi, al paziente verrà rilasciata richiesta degli stessi. Una volta accomodato fuori l'ambulatorio, la cartella clinica viene consegnata in accettazione, dove provvederanno al controllo e all'archiviazione.

Le periodicità delle visite di idoneità sono definite dai Medici Specialisti tenendo in considerazione le indicazioni previste dalle tabelle delle Federazioni Sportive Nazionali aderenti al CONI e dall'esito della visita medico sportiva.

- Al termine della visita

Al termine della visita il personale in accettazione deve controllare che tutta la documentazione necessaria sia presente in cartella. Ogni cartella deve contenere tutta la modulistica compilata in fase di accettazione e sopra descritta:

- copia del certificato di idoneità sportiva;
- stampa dei tracciati elettrocardiografici;
- eventuali copie di esami portati in visione al medico;
- eventuale copia della richiesta di esami aggiuntivi;
- copia dell'antitetanica (nel caso di visita agonistica);
- stampa della spirometria (nel caso di visita agonistica);
- referto delle urine (nel caso di visita agonistica).
- il consenso informato

Tutte le visite sono poi registrate nell'archivio digitale inserendo i dati richiesti, l'esito della visita, ed il codice identificativo della cartella per poterla ritrovare all'interno dell'archivio fisico.

Al termine del periodo previsto dalla USL (diverso per ogni sezione), i dati delle visite eseguite dovranno essere inviati secondo le modalità comunicate.

Gestione dei sospesi

Gli esami richiesti durante la visita sportiva dal medico dello sport devono essere portati entro 60 giorni dalla data di visita, al termine dei quali verrà eseguito il rigetto della visita. Il paziente deve contattare la struttura presso la quale ha eseguito la visita per portare gli esami richiesti dal medico dello sport in visione. Il personale di accettazione si occupa di prenotare l'appuntamento con il

medico o di inviare gli esami eseguiti, in modo tale che il medico possa visionarli e decidere se consegnare o meno il certificato di idoneità sportiva.

Gestione dei non idonei

Se durante una visita il medico dovesse rilasciare un certificato di non idoneità, sarà necessario inviare 4 notifiche con raccomandata A/R a:

- Commissione regionale di appello
- Soggetto dichiarato non idoneo a cui si allega il libretto medico-sportivo (può essere anche consegnata a mano al diretto interessato con firma di ricevuta)
- Medicina dello Sport ASL
- Società Sportiva a cui si allega il certificato con il giudizio di NON IDONEITÀ.

Le notifiche vanno inviate entro 5 giorni dalla data di non idoneità e, per ogni notifica, andrà fatta una copia da conservare in cartella e a cui si spillerà la ricevuta di ritorno.

Idoneità attività sportiva durante emergenza sanitaria Coronavirus

Il processo di valutazione dell'idoneità all'attività sportiva degli atleti, in accordo con quanto previsto dalla circolare ministeriale del Ministero della Salute del 13/01/2021, deve prendere in considerazione l'emergenza sanitaria COVID19 e le conseguenze sullo stato di salute degli atleti stessi, prendendo in considerazione anche le complicanze maggiori e più frequenti. Occorre quindi valutare nella sua globalità l'atleta guarito da Covid-19, specie nelle forme più severe, per il possibile coinvolgimento di diversi organi ed apparati. In un'ottica di tutela del Paziente, è obbligo del Direttore Sanitario, richiedere l'esecuzione di test e/o esami aggiuntivi in accordo con quanto stabilito dal Ministero della Salute e dalla eventuale normativa regionale di riferimento. Grande attenzione dovrà essere posta in caso di ripresa dell'attività sportiva di un atleta risultato positivo o con sintomi equiparabili in un periodo di tempo compatibile con la circolazione del virus.

Il Medico, in sede iniziale, dovrà distinguere gli atleti in:

- A. Atleti Covid-19+ (positivi) accertati e con guarigione accertata secondo la normativa vigente, ed atleti che, pur non avendo ricevuto una diagnosi di infezione da Sars-COV-2, abbiano sviluppato una sintomatologia suggestiva di Sars-COV-2 (e cioè, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) in un periodo compatibile con la circolazione del virus. Pertanto, a giudizio del medico valutatore, gli atleti saranno suddivisi, secondo la classificazione (Tabella 1) dei National Institutes of Health (NIH) riportata anche nella Circolare del Ministero della Salute del 30/11/20 recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-COV-2" in:
 - a. A1. Atleti che hanno presentato "Infezione asintomatica o presintomatica" o "Malattia lieve" e che comunque non siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da Sars-COV-2;
 - b. A2. Atleti che hanno presentato "Malattia moderata" o che comunque siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da Sars-COV-2;
 - c. A3. Atleti che hanno presentato "Malattia severa" o "Malattia critica"
- B. Atleti Covid-19- (negativi) e atleti asintomatici (non testati) nel periodo della pandemia

Approfondimenti diagnostici

Gruppo A1: La visita medica e gli esami strumentali e di laboratorio devono essere integrati con i seguenti approfondimenti diagnostici:

1. Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico (ECG) e valutazione della saturazione di O₂ a riposo, durante e dopo il test;

2. Ecocardiogramma color-Doppler;
3. Esame spirometrico con determinazione di: capacità vitale forzata (FVC), volume espiratorio forzato al primo secondo (FEV-1), indice di Tiffenau, picco di flusso espiratorio e flussi a volumi intermedi, e massima ventilazione volontaria (MVV).

Gli esami devono essere eseguiti non prima che siano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta guarigione da Sars-Cov2, o non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta scomparsa dei sintomi per gli atleti che non hanno ricevuto una diagnosi certa di infezione da Sars-COV-2 mediante test molecolare.

Gruppo A2: La visita medica e gli esami strumentali e di laboratorio devono essere integrati con i seguenti approfondimenti diagnostici:

1. Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico e valutazione della saturazione di O₂ a riposo, durante e dopo il test;
2. Ecocardiogramma color doppler;
3. ECG Holter 24hr inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo;
4. Esame spirometrico con determinazione di: capacità vitale forzata (FVC), volume espiratorio forzato al primo secondo (FEV-1), indice di Tiffenau, picco di flusso espiratorio e flussi a volumi intermedi, e massima ventilazione volontaria (MVV);
5. Esami ematochimici (Emocromo completo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi cardiaci, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, PCR, Ferritina, Esame urine completo).

A giudizio del medico valutatore la visita medica potrà essere integrata con:

- Diagnostica per immagini polmonare;
- Diffusione alveolo-capillare;
- Valutazione cardiopolmonare integrata durante test ergometrico incrementale massimale (cardiopulmonary exercise test – CPET).

Gli approfondimenti diagnostici vanno eseguiti non prima che siano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta guarigione da Sars-Cov-2, documentata con test molecolare RT-PCR negativo.

Gruppo A3: La visita medica e gli esami strumentali e di laboratorio devono essere integrati con i seguenti approfondimenti diagnostici:

1. Valutazione cardiopolmonare integrata durante test ergometrico incrementale massimale (cardiopulmonary exercise test – CPET), con monitoraggio ECG e con valutazione della saturazione di O₂ a riposo, durante e dopo test;
2. Ecocardiogramma color-Doppler;
3. ECG Holter 24hr, inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo;
4. Esame spirometrico con determinazione di FVC, FEV1 e MVV;
5. Esami ematochimici (Emocromo completo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi cardiaci, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, PCR, Ferritina, Esame urine completo).

A giudizio del medico valutatore la visita medica potrà essere integrata con:

- Diagnostica per immagini polmonare;
- Diffusione alveolo-capillare.

Gli approfondimenti diagnostici vanno eseguiti non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta guarigione da Sars-Cov-2, documentata con test molecolare RT-PCR negativo.

NOTA BENE

È facoltà del medico valutatore richiedere ulteriori accertamenti, qualora nel corso della visita medica e/o da quanto emerso dalla documentazione esaminata ne ravvisi la necessità. Una volta ultimato l'iter di esami, il medico valutatore, rilascerà:

1. Il Certificato di idoneità alla pratica dello sport agonistico in caso di primo rilascio/rinnovo periodico della visita medica;
2. L'Attestazione di "Ritorno all'attività" Allegato C Return to play (Circolare Ministero della Salute 0001269-13012021) da conservare in copia all'interno della cartella del paziente, unitamente alle risultanze della visita medica e degli accertamenti eseguiti, in caso di sopraggiunta infezione da Sars-CoV-2 con certificazione in corso di validità.

Tutti gli atleti al termine della visita dovranno sottoscrivere il documento denominato "Allegato A Circolare Ministero della Salute 0001269-13012021" (da conservare in copia nella cartella).

Qualora l'infezione da Sars-COV-2 sopraggiunga in corso di validità della certificazione di idoneità alla pratica dello sport agonistico, oppure qualora l'atleta manifesti una sintomatologia suggestiva di Sars-COV- 2 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) successivamente alla data di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, l'atleta è tenuto ad informare - oltre che il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta - il Medico Sociale (ove presente) della Società/Federazione Sportiva Nazionale/Ente di Promozione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata e, ad avvenuta guarigione, a trasmettere al Medico Specialista in Medicina dello Sport l'"Allegato B Circolare Ministero della Salute 0001269-13012021" (da conservare in copia nella cartella), affinché possa essere valutata l'opportunità di procedere al rilascio dell'attestazione di "Ritorno all'attività" come da Allegato C Return to play (Circolare Ministero della Salute 0001269-13012021).